

UBA
Universidad de Buenos Aires

Trabajo Práctico Grupal de Laboratorio de Métodos Cuantitativos

Mortalidad por Suicidios en Argentina Durante el Período 2020–2024

INTEGRANTES Y NUMERO DE REGISTRO:

Miguelina Baldi	- 920085
Aldana Montenegro	- 921489
Micaela Cabrera Herrera	- 921458
Florencia Scavone	- 921420
Kayra Estrella	- 921472

Resumen

Este trabajo analiza la mortalidad por suicidio en Argentina entre 2020 y 2024 según año, edad, sexo y provincia. Se integraron dos fuentes oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC): una base provincial agregada y una base de microdatos con un registro por víctima; ambas coinciden exactamente en 19.323 víctimas. Los casos registrados pasaron de 3.262 en 2020 a 4.249 en 2024 (+30,3 %), aunque el aumento se desaceleró hasta 1,05 % en el último año. El 78,97 % de las víctimas son varones y la razón varones/mujeres osciló entre 3,57 y 4,24. Entre los casos con edad conocida, las franjas de 20 a 24 y de 25 a 29 años son las más numerosas. Buenos Aires concentra el 29,97 % de los casos, pero el peso en cantidad de casos no equivale a mayor riesgo relativo, por lo que se compararon también tasas por 100.000 habitantes.

Introducción

El suicidio constituye una problemática de salud pública grave, compleja y fundamentalmente prevenible en la Argentina. La **motivación** principal para llevar a cabo esta investigación surge de la constante y preocupante repetición de esta problemática en la agenda social y sanitaria actual, un fenómeno cuyo impacto recurrente vuelve indispensable y oportuno profundizar en el análisis cuantitativo de sus dimensiones demográficas y sus tendencias temporales. En este sentido, se definió el año 2020 como punto de partida para evaluar el comportamiento de esta problemática a partir de la crisis sanitaria por el COVID-19 y sus consecuencias en la etapa de pospandemia.

Para abordar esta situación con rigor analítico y desde una perspectiva objetiva, el **dataset** elaborado consolida e integra de manera sistemática los registros oficiales de hechos acontecidos en todo el territorio nacional. La **fuente** de información primaria proviene de las bases de datos abiertos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), área gestionada por la Dirección Nacional de Estadística Criminal (DNEC) y dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. En este trabajo se articulan dos fuentes complementarias: la serie provincial agregada y la base de microdatos unificados correspondiente al período 2020–2024, lo que permite evaluar tanto el panorama general del país como los desgloses sociodemográficos específicos a nivel individual.

A partir de este marco contextual y metodológico, la **pregunta principal** que guía e impulsa la investigación es: *«¿Cómo evolucionó la mortalidad por suicidio en Argentina entre 2020 y 2024, qué franja etaria concentra la mayor vulnerabilidad y cómo se comporta la brecha entre varones y mujeres a lo largo de este período?»*.

Metodología y Fuentes de Datos

Fuentes de Información y Estructura

Para realizar este trabajo utilizamos dos fuentes de datos oficiales de la Dirección Nacional de Estadística Criminal (DNEC) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC):

- **Base provincial agregada:** Tiene 26.528 filas y 14 columnas, y abarca las 24 jurisdicciones del país entre 2000 y 2025. No presenta filas duplicadas y sus valores nulos (16.688 filas) corresponden a otros delitos que no forman parte de este estudio. La categoría de interés, *«Suicidios (consumados)»*, está completa.
- **Base de microdatos por víctima:** Contiene 30.177 registros y 27 columnas para el período 2017–2024. En esta base, cada fila representa a una víctima individual con información sobre sexo, tramo de edad, provincia, fecha y modalidad. Para el período 2020–2024 no tiene duplicados, y los datos faltantes corresponden únicamente a variables descriptivas secundarias (como `tipo_lugar_otro` o `modalidad_otro`) y a dos identificadores departamentales que no utilizamos en el análisis.

Transformaciones y Limpieza de Datos

El procesamiento y la limpieza de las bases los realizamos en `Python` utilizando las librerías `Pandas` y `Matplotlib`. Las principales transformaciones que aplicamos fueron:

1. **Filtro por período y delito:** Filtramos ambas fuentes para quedarnos únicamente con los suicidios registrados entre 2020 y 2024. Así, la base provincial quedó reducida a 120 observaciones (24 provincias $\times$ 5 años) y la de microdatos a 19.323 registros, logrando que ambas fuentes describan exactamente el mismo período y total de casos.
2. **Integración de las bases (*Merge*):** Agrupamos los microdatos por año y provincia y los vinculamos con la tabla provincial mediante la función `merge`. Elegimos esta opción en lugar de `concat` porque las fuentes tienen distinta unidad de observación (totales por provincia frente a casos individuales), por lo que apilarlas habría mezclado niveles y duplicado conteos. Luego, unimos cada registro individual con los datos de su provincia y año, obteniendo una base máster de 19.323 filas y 39 columnas.
3. **Ordenamiento de tramos de edad:** Convertimos la variable de edad en una categoría ordenada (desde «5–9» hasta «90 y más») para que al generar las tablas y gráficos se respete el orden biológico natural y no el alfabético.
4. **Manejo de la categoría «Sin determinar»:** Para el análisis por edad excluimos 844 casos sin edad declarada, trabajando con una muestra efectiva de 18.479 registros. Sin embargo, en la base general mantuvimos los 19.323 casos para no alterar el total nacional de víctimas.

Controles de Calidad y Procesamiento

Como control de calidad, verificamos que los 120 cruces año-provincia coincidieran perfectamente entre ambas bases, dando una diferencia de cero víctimas y validando el total nacional de 19.323 casos.

Respecto a los datos no declarados, la categoría «Sin determinar» representa 844 casos en edad y 132 en sexo, teniendo su punto más alto en 2023 (5,35 % en edad y 1,38 % en sexo). Decidimos no eliminar estos registros para conservarlos como una limitación propia de la fuente.

Resultado e Interpretación

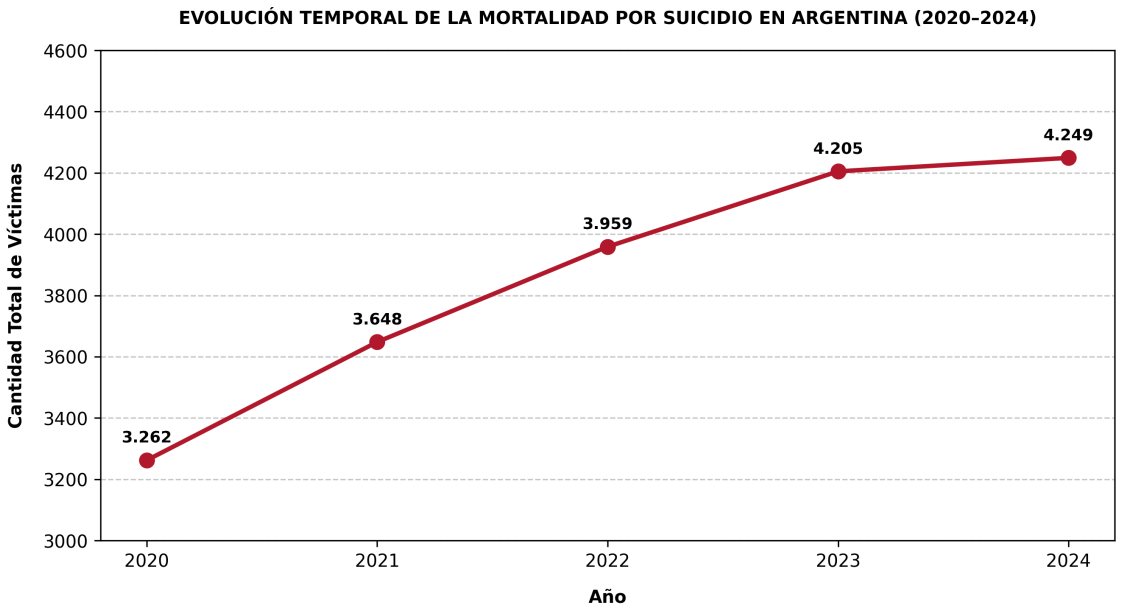


Figura 1: Evolución Temporal de casos durante 2020–2024

Interpretación: El gráfico muestra una curva ascendente en la mortalidad por suicidio en Argentina entre 2020 y 2024, pasando de 3.262 a 4.249 víctimas anuales, lo que representa un incremento acumulado del 30,25 % en la serie analizada. Aunque hacia 2024 se observa un estancamiento en la velocidad del crecimiento (un incremento interanual de solo 1,05 %), la meseta se ubica en el nivel más alto registrado en los últimos años.

Para comprender las razones detrás de esta tendencia alcista, la literatura especializada e informes del ámbito de la salud poblacional señalan factores estructurales y coyunturales clave:

En primer lugar, el nivel de 2020 no debe interpretarse como una cifra de bajo riesgo real, sino como un piso influenciado por las restricciones severas de movilidad durante la pandemia por COVID-19. El confinamiento inicial generó un diferido en la manifestación de secuelas emocionales, desencadenando en los años posteriores una ola secundaria de cuadros graves de depresión, trastornos de ansiedad y consumo problemático de sustancias en la población.

En segundo lugar, el incremento sostenido responde a determinantes socioeconómicos estructurales. La profundización de la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre económica actuaron como estresores psicosociales permanentes, debilitando las trayectorias de vida de los sectores más vulnerables.

Por último, el fenómeno se ve agravado por la erosión de las redes comunitarias de contención y las marcadas barreras de acceso al sistema integral de salud (tanto en el sector público como en el privado). La distribución inequitativa de recursos profesionales e infraestructura sanitaria en el país limita la detección temprana y la atención oportuna en situaciones de crisis, consolidando una problemática sanitaria compleja y multicausal a nivel nacional.

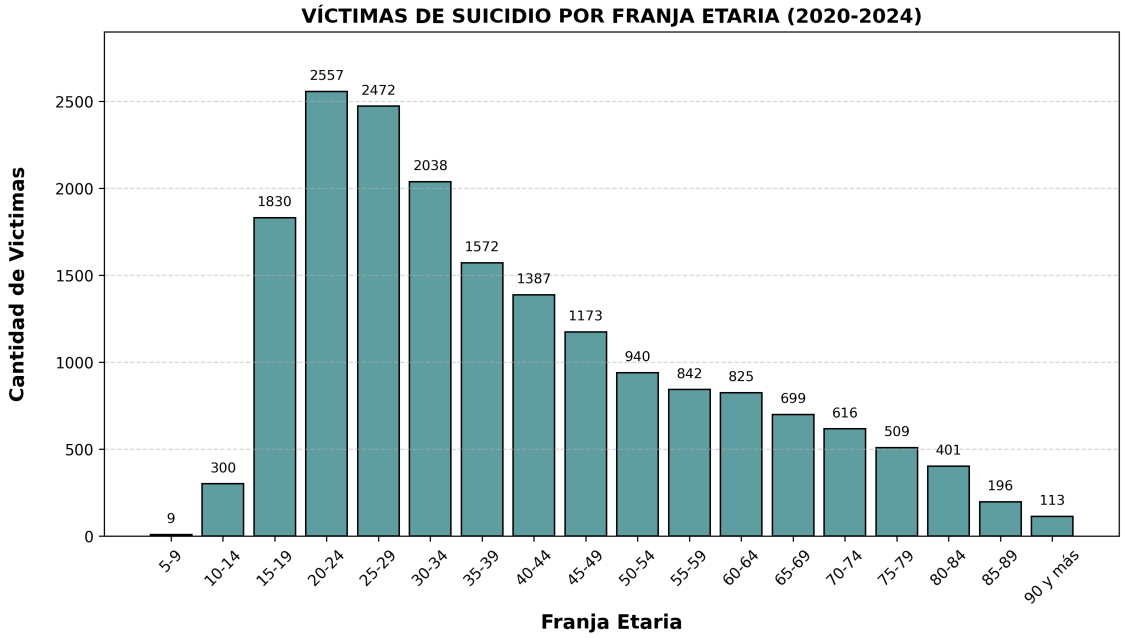


Figura 2: Víctimas de Suicidio por Franja Etaria

Interpretación: El análisis de la mortalidad por suicidio en Argentina entre 2020 y 2024 revela una problemática crítica focalizada en la juventud: la franja de 15 a 34 años concentra 8.897 víctimas, alcanzando su pico máximo entre los 20 y 24 años (2.557 casos) para luego descender de forma paulatina a partir de los 35 años. Esta concentración en etapas tempranas de la vida guarda directa correspondencia con los informes y alertas de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cuales posicionan a las lesiones autoinfligidas como una de las principales causas de muerte externa en adolescentes y jóvenes en la región.

La alta incidencia en esta población responde a una trama multicausal caracterizada por la intersección de factores de vulnerabilidad psicosocial y transformaciones estructurales del contexto socioeconómico. Por un lado, la transición hacia la vida adulta se desarrolla dentro de un contexto atravesado por la precariedad laboral, la inestabilidad y la incertidumbre respecto a la construcción de proyectos de vida autónomos, lo que genera tensiones y cargas psíquicas continuas. A esto se le suma el impacto diferido de la pospandemia, donde el quiebre prolongado de las trayectorias educativas, la pérdida de espacios institucionales de pertenencia y la discontinuidad de rutinas sociales derivaron en una intensificación de cuadros severos de ansiedad, depresión y desestructuración afectiva en sectores jóvenes.

Asimismo, la problemática se ve moldeada por las dinámicas del entorno digital y virtual. Si bien las redes sociales funcionan como espacios de interacción, también han intensificado situaciones de aislamiento afectivo, comparación social dañina y ciberacoso, dificultando la consolidación de redes comunitarias e interpersonales presenciales que actúen como factores de protección y contención emocional ante situaciones de crisis.

Frente a la magnitud de este escenario, la Ley Nacional N.º 27.130 de Prevención del Suicidio y su Decreto Reglamentario 603/2021 constituyen un hito fundamental al establecer el derecho a la atención interdisciplinaria, la capacitación docente y la creación de líneas de asistencia. Sin embargo, el principal desafío radica en acortar la brecha entre el marco normativo y su implementación efectiva, garantizando que los recursos de detección temprana, los dispositivos de apoyo en el ámbito escolar y universitario, y los centros de contención territorial funcionen de manera articulada, accessible y libre de estigmas para la población joven en todo el país.

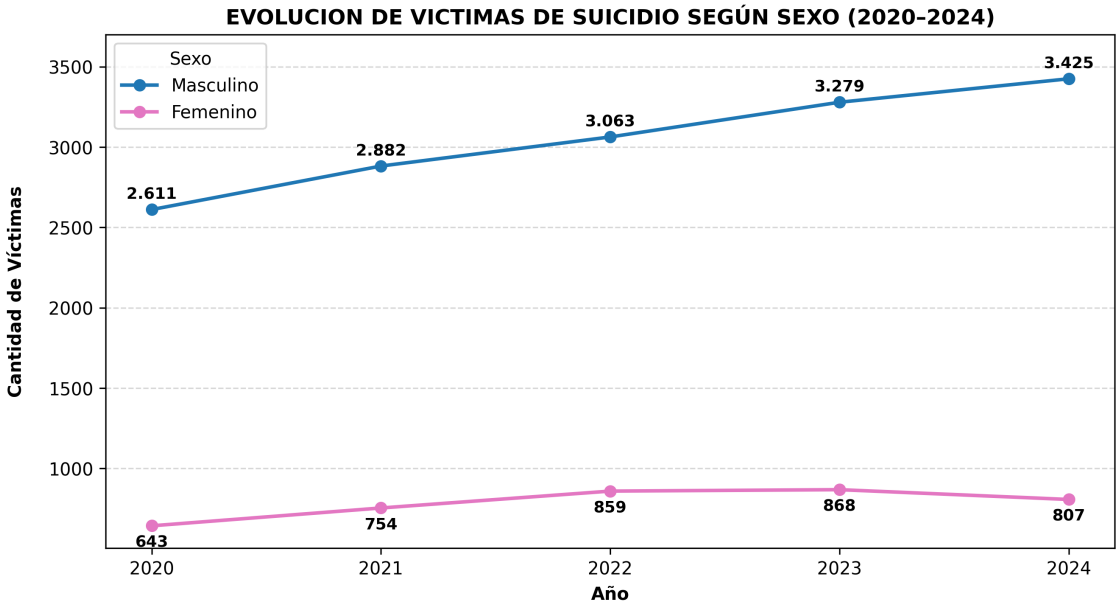


Figura 3: Víctimas de Suicidio por Sexo

Interpretación: El gráfico de líneas compara la cantidad anual de suicidios entre varones y mujeres en Argentina entre 2020 y 2024, evidenciando una marcada y constante brecha de género a lo largo de todo el período analizado. Mientras que la serie masculina muestra un ascenso continuo que parte de 2.611 casos en 2020 y alcanza un pico de 3.425 en 2024, la serie femenina registra valores considerablemente menores, oscilando entre un piso de 643 en 2020 y un máximo de 868 en 2023, para cerrar en 807 en 2024. Los varones concentran de manera sistemática entre el 80 % y el 82 % del total de muertes consumadas, lo que significa que, en promedio, por cada mujer que fallece por esta causa, fallecen cuatro hombres.

Esta disparidad sostenida responde a una trama sociocultural y clínica compleja que excede la mera descripción de las cifras. Un factor determinante radica en la elección de los mecanismos empleados: estadísticamente, los varones recurren a métodos de mayor letalidad e irreversibilidad inmediata, lo que reduce de forma drástica los márgenes de maniobra para la intervención médica de urgencia o el rescate a tiempo.

En términos psicosociales, los mandatos tradicionales de la masculinidad operan como un sesgo silencioso en la prevención. La exigencia social de autosuficiencia, la represión de la vulnerabilidad emocional y el estigma asociado al malestar psíquico actúan como una barrera para la búsqueda de ayuda profesional temprana, haciendo que los hombres consulten significativamente menos a los servicios de salud mental. Esta reticencia a verbalizar el sufrimiento se traduce también en una marcada fragilidad en las redes interpersonales entre pares, donde el aislamiento afectivo suele prevalecer frente a situaciones de pérdida de empleo, quiebres vinculares o crisis financieras.

A esta coyuntura se suma un frecuente subdiagnóstico clínico de depresión y de conductas de riesgo hacia sí mismos en varones. La sintomatología depresiva masculina suele exteriorizarse a través de agresividad, irritabilidad, comportamientos impulsivos o abuso de sustancias, en lugar de expresarse mediante manifestaciones afectivas convencionales como el desánimo explícito o la apatía. En consecuencia, el sufrimiento psíquico queda invisibilizado para el entorno cercano y los equipos de salud, postergando el abordaje terapéutico hasta instancias críticas. Esta realidad evidencia la urgencia de diseñar políticas sanitarias con perspectiva de masculinidad que trasciendan la consulta clínica convencional e incorporen estrategias de abordaje comunitario, sindical y territorial.

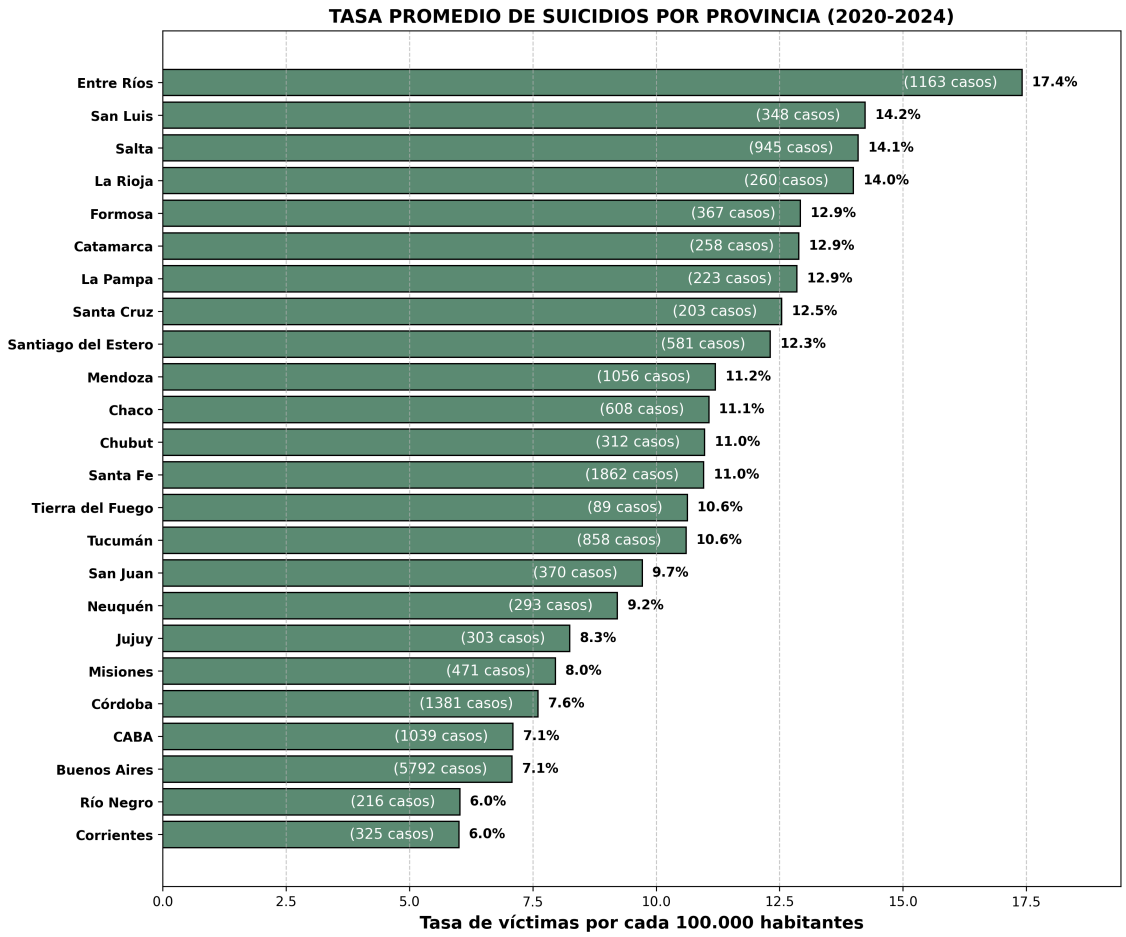


Figura 4: Promedio de Suicidios por cada 100.000 Habitantes por Provincia

Interpretación:

El gráfico ordena las provincias según su tasa promedio de suicidios por 100.000 habitantes entre 2020 y 2024, indicando el volumen absoluto de casos entre paréntesis. En este sentido, el uso de la tasa ajustada resulta indispensable para corregir el sesgo demográfico, evitando así sobreestimar el impacto en las grandes metrópolis y visibilizando la situación crítica en aquellas jurisdicciones con menor escala poblacional.

Al analizar la distribución geográfica, se observa una marcada disparidad entre la capital del país y las provincias subnacionales. Mientras que jurisdicciones como Entre Ríos (17,4 % por cada 100.000 habitantes) y San Luis (14,2 %) encabezan el ranking con las tasas más elevadas del período analizado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica en el extremo inferior con un 7,1 %. Esta divergencia responde fundamentalmente a una acentuada inequidad en la distribución de la infraestructura sanitaria: por una parte, CABA concentra la mayor densidad de profesionales de la salud mental, dispositivos asistenciales y guardias de urgencia, lo que favorece la detección temprana y la intervención oportuna; por otra parte, en las demás jurisdicciones operan barreras geográficas que dificultan el acceso a los servicios de salud, a las que se suma el fuerte estigma social en comunidades más reducidas, donde la exposición pública desincentiva la búsqueda confidencial de asistencia psicológica.

De manera complementaria, los determinantes socioeconómicos y la precarización laboral impactan de forma diferenciada según la región. Por consiguiente, para resolver esta inequidad territorial, la asignación presupuestaria y la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.130 deben seguir una estricta lógica federal que priorice a las jurisdicciones con mayores tasas de mortalidad, descentralizando los dispositivos de asistencia y fortaleciendo las redes comunitarias locales.

Reflexión Metodológica

El desarrollo del presente informe contó con el apoyo puntual de modelos de Inteligencia Artificial Generativa (tales como Gemini, Claude, DeepSeek y ChatGPT), utilizados exclusivamente como recurso de consulta técnica ante dudas específicas. En la etapa de procesamiento de datos, las herramientas sirvieron de guía sintáctica para la escritura y optimización de scripts en `Python` (Google Colab), facilitando la resolución de dificultades durante la limpieza e integración de las bases del SNIC y la maquetación de gráficos en `Matplotlib`. Asimismo, en la fase de edición, se recurrió a este soporte ante consultas de formato en LaTeX y para orientar la redacción hacia un registro socioepidemiológico formal.

Para asegurar la precisión y el rigor académico del documento, el equipo llevó a cabo una revisión en dos instancias:

1. **Validación cuantitativa:** Se contrastaron manualmente los resultados del código y las visualizaciones con las tablas originales de la fuente, verificando la exactitud de los valores numéricos, porcentajes y razones por sexo.
2. **Auditoría cualitativa:** Se revisó la coherencia teórica del análisis, garantizando que las interpretaciones se ajustaran estrictamente a las variables observadas en los gráficos y reflejara la naturaleza multicausal del fenómeno.

Bibliografía

Chequeado. (2026). *El suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos en Argentina*. Centro de Datos. https://chequeado.com/el-explicador/el-suicidio-ya-es-la-principal-causa-de-muerte-entre-adolescentes-y-jovenes-adultos-en-argentina/
Aporte: Análisis de la tendencia alcista post-pandemia e incremento de cuadros de depresión y ansiedad en la población.

Infobae. (2026, 21 de agosto). *El aumento de los suicidios en Argentina preocupa a los especialistas en salud mental*. Sección Salud. https://www.infobae.com/salud/2026/08/21/el-aumento-de-los-suicidios-en-argentina-preocupa-a-los-especialistas-en-salud-mental/
Aporte: Visión cualitativa sobre determinantes socioeconómicos y el diferido de las secuelas emocionales del aislamiento.

Diario La Nueva. (2026, 14 de septiembre). *Récord de suicidios en Argentina: por qué aumentaron como nunca antes en la historia del país*. https://www.lanueva.com/nota/2026-9-14-14-17-0-record-de-suicidios-en-argentina-por-que-aumentaron-como-nunca-antes-en-la-historia-del-pais
Aporte: Contexto histórico y factores de riesgo en el incremento sostenido del quinquenio.

Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS). (2023). *Estadísticas Vitales: Información de Mortalidad y Natalidad en Argentina*. Ministerio de Salud de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/salud/deis
Aporte: Registros vitales de mortalidad por lesiones autoinfligidas en adolescentes y jóvenes de 15 a 34 años.

Ley N.º 27.130. *Ley Nacional de Prevención del Suicidio*. Honorable Congreso de la Nación Argentina, 11 de marzo de 2015. Reglamentada por el Decreto 603/2021.
Aporte: Marco normativo nacional y protocolos de contención territorial para la población vulnerable.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) & Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). *Masculinidad y el suicidio entre hombres en las Américas*. Hoja informativa institucional. https://www.paho.org/es/documentos/hoja-informativa-masculinidad-suicidio-entre-hombres-americas
Aporte: Fundamento epidemiológico sobre letalidad de métodos, mandatos de masculinidad y subdiagnóstico.

SciELO Argentina. (2022). *Análisis epidemiológico de las tendencias de mortalidad por causas externas y diferencia por sexo en Argentina*. Revista Argentina de Salud Pública, 14, e75. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-810X2022000100075
Aporte: Evidencia empírica y patrones de diferencia por sexo en muertes por causas externas.

Chequeado. (2025). *Suicidios en Argentina: qué provincias tuvieron las tasas más altas y cómo se distribuyen los recursos de salud mental*. Centro de Datos. https://chequeado.com/el-explicador/suicidios-en-argentina-que-provi

ncias-tuvieron-las-tasas-mas-altas-en-2025-y-como-se-distribuyen-los-psiquiatras/
Aporte: Justificación teórica sobre el sesgo de la masa bruta de casos y prioridad de tasa por 100.000 habitantes.

Ministerio de Salud de la Nación. (2024). *Boletín Epidemiológico Nacional: Estrategias de Prevención del Suicidio y Distribución Territorial*. Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica. https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional
Aporte: Análisis de disparidades sanitarias e infraestructura de salud mental en las provincias del interior.